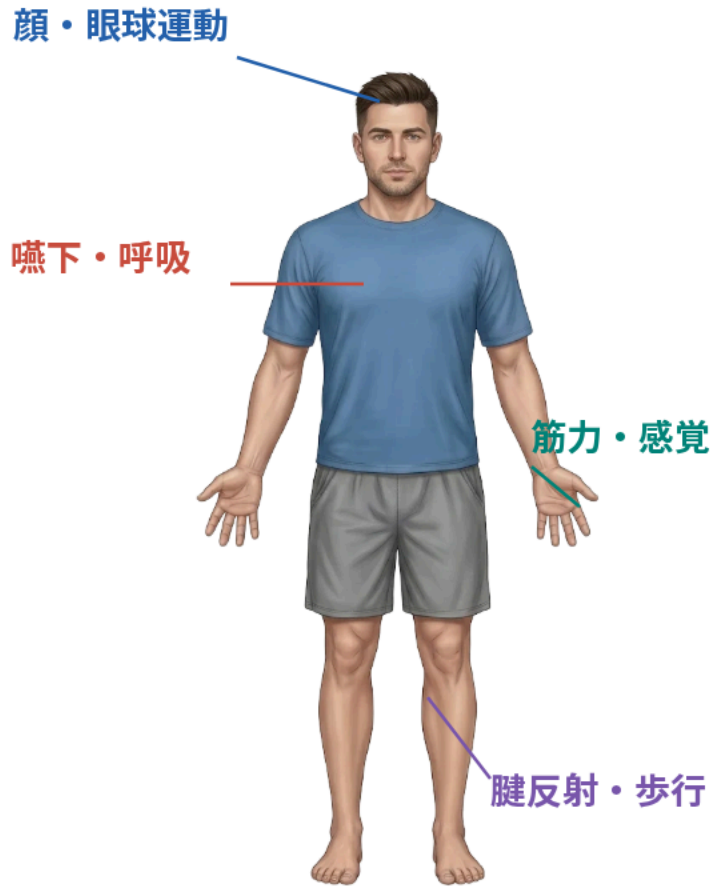
初期評価

両側顔面神経麻痺の鑑別と初期評価

呼吸・嚥下を守り、全身所見から検査を選ぶ



診察部位の参考図（症例像ではありません）

医療者向け：鑑別と初期評価

顔面運動・時間経過・全身所見から考える

一般的な医学情報です。個別の診断・治療に代わるものではありません。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Molinari et al. 2023（詳細は記事参考文献）

図：Human Bio Media／CC BY 4.0（原画無変更）　Access for free at https://humanbiomedia.org/

初診では安全確保と原因検索を並行する

緊急性の評価、診察と記録、原因検索は同時に進める

安全確保	呼吸・嚥下・咳・循環を評価。閉眼不全があれば角膜も保護する。	**悪化なら監視・管理を優先**
経過の記録	左右の発症日、進行、改善、過去の麻痺と再発を確認する。	**左右別の時間軸に整理**
原因の検討	顔以外の所見から局在と仮説を考え、目的に応じ検査する。	**結果と経過が合わなければ再評価**

安全確保を先送りせず、原因を調べながら経過を見直します。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019 ／ Yang & Dalal 2021（詳細は記事参考文献）

緊急性を変えるのは顔以外の所見

症状の組合せによって、急いで評価する病態が変わる

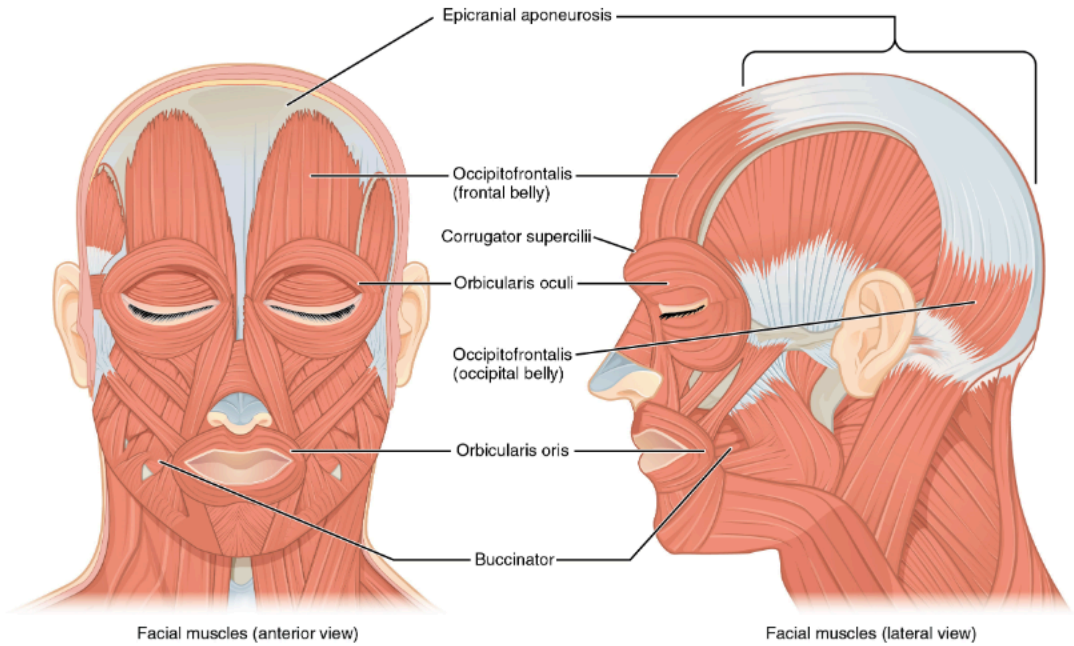
所見の組合せ	優先する評価・対応
呼吸機能低下・嚥下障害・弱い咳	監視と呼吸管理の必要性を検討
突然発症＋眼球運動・四肢の異常	脳幹の急性病変を評価
発熱＋頭痛・項部硬直	髄膜炎を評価
急速な脱力・不整脈・血圧変動	全身の安全確保を優先

顔面麻痺の強さだけで緊急性を決めません。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019 ／ Min & Jung 2019（詳細は記事参考文献）

左右差ではなく左右それぞれの運動を見る

顔のゆがみが乏しくても、両側の筋力低下はあり得る



正常解剖図（前面・側面）。麻痺の症例像ではありません

額：前頭筋／閉眼：眼輪筋／口：口輪筋・頬筋

額・閉眼

眉を上げる動作と、しっかり目を閉じる動作を左右それぞれで確認します。

口の運動

歯を見せる、頬を膨らませる動作を確認し、口角の位置だけでは判断できません。

安静時と運動時

額・閉眼・口の動きを左右別に記録。閉眼時の眼の露出も確認します。

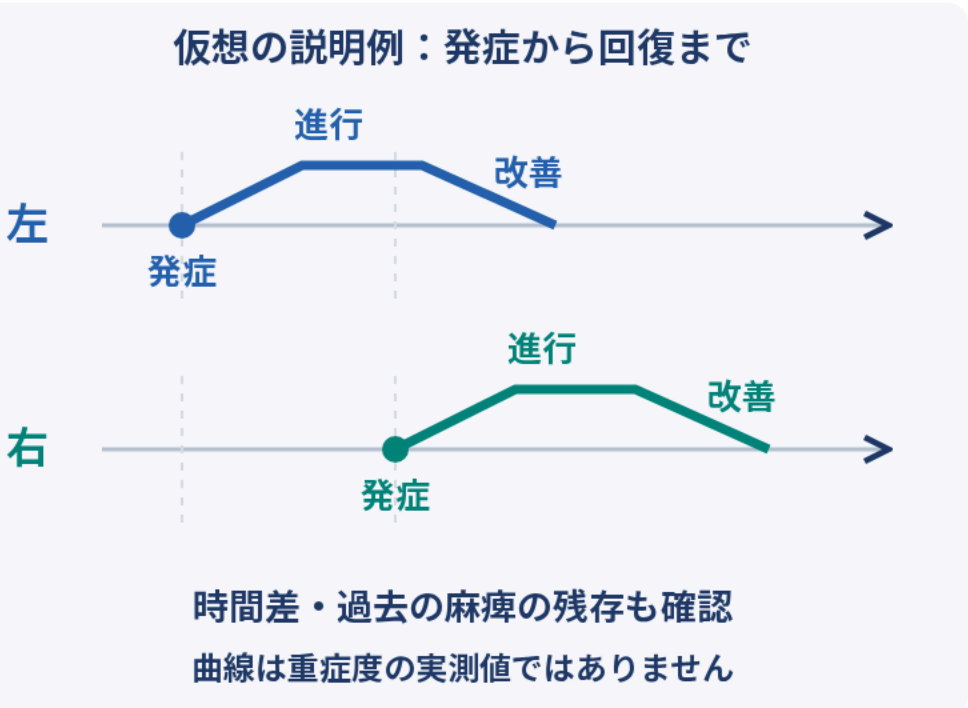
見た目の対称性と、顔面筋力が正常であることは別です。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Pauna et al. 2024（詳細は記事参考文献）

図：OpenStax, Anatomy & Physiology, Fig. 11.6／CC BY 4.0（原画無変更）

左右の発症と回復を同じ時間軸に置く

同時発症、時間差、過去の麻痺の残存を区別する



左右の発症日

左と右の発症を別々に聞き、同じ時間軸に置きます。

発症後の変化

進行した時期と改善した時期、反復の有無を確認します。

既往との関係

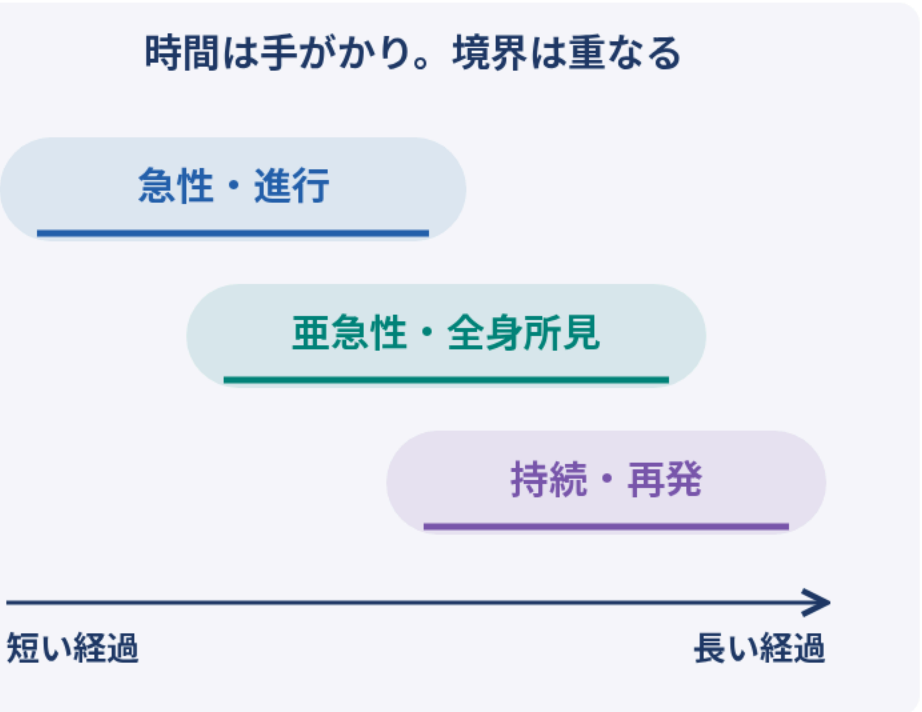
古い片側麻痺に新しい麻痺が加わった可能性も検討します。

仮想の説明例です。曲線の高さや幅は実測値ではありません。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Molinari et al. 2023（詳細は記事参考文献）

発症速度は候補を変えるが病名を決めない

急性・亜急性・慢性という印象だけで鑑別を固定しない



突然の発症

血管障害を含め、急性の病変を評価します。

急速に進行する経過

感染、免疫性疾患、外傷などを病歴と合わせて検討します。

緩徐な進行

腫瘍や炎症なども候補です。経過だけでは確定・除外できません。

時間帯は重なります。図は診断基準や期間の閾値を示していません。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Min & Jung 2019 ／ Molinari et al. 2023（詳細は記事参考文献）

「どの病気か」の前に「どこが障害されたか」

顔面筋の弱さが、すべて顔面神経そのものの障害とは限らない

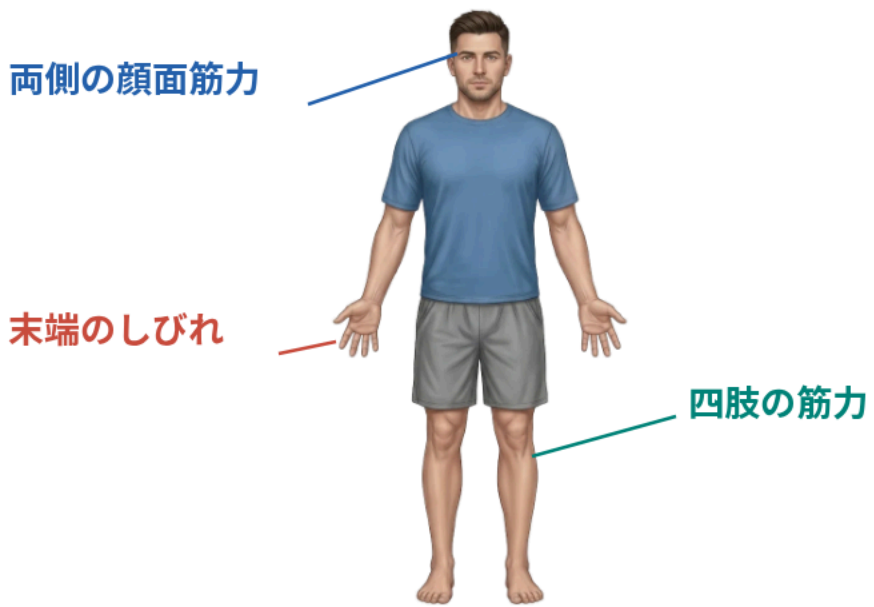
脳幹	→	突然発症・眼球運動・四肢の異常	→	**橋の病変を検討**
顔面神経	→	反射・末端感覚・髄膜症状・全身所見	→	**GBS、感染、炎症、腫瘍など**
神経筋接合部	→	活動で増悪・休息で改善、眼・球症状	→	**MGなどを検討**
顔面筋の運動	→	額・閉眼・口の動きを左右別に確認	→	**弱さだけでは原因は確定しない**

経路の順序や図の面積は、疾患の頻度・順位とは無関係です。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Min & Jung 2019 ／ MedlinePlus MG 2025（詳細は記事参考文献）

四肢の筋力が保たれていてもGBSは残る

両側顔面筋力低下と末端の異常感覚という組合せ



分布・筋力・腱反射を組み合わせる
診察部位の参考図（症例像ではありません）

顔面型のGBSを念頭に

顔面筋力低下が目立ち、四肢脱力はないか軽い場合があります。

手足の感覚と腱反射

末端優位の異常感覚、反射の低下・消失を確認します。

時間経過と先行感染

下痢や呼吸器感染などの先行感染、症状の進行を合わせて評価します。

四肢の筋力が保たれているという一点だけで、GBSは除外できません。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Susuki et al. 2009（詳細は記事参考文献）

図：Human Bio Media／CC BY 4.0（原画無変更）　Access for free at https://humanbiomedia.org/

顔面型GBS：強い所見と乏しい所見を組み合わせる

四肢の強い脱力を必須条件にすると、顔面型を捉えにくい

目立つ所見	乏しいことがある所見	診察での意味
急性進行性の両側顔面筋力低下	四肢脱力	顔以外の筋力も実際に評価
末端優位の異常感覚	失調	感覚と歩行を別々に確認
腱反射の低下・消失	他の脳神経障害	単一所見で判断せず組合せを検討

選択された症例の原著抄録に基づく特徴です。一般患者の頻度ではありません。

主な出典：Susuki et al. 2009（詳細は記事参考文献）

初期の正常所見は再評価計画とセットで扱う

発症・初回診察・検査の時期をそろえて解釈する

評価項目	初期にあり得る所見	疑いが残る場合
腱反射	病初期には正常のことがある	症状とともに診察所見を追う
神経伝導検査（NCS）	初回検査が正常のことがある	経過に応じて再検を検討
髄液	早期には蛋白細胞解離を欠く	検査時期と臨床像を合わせて再評価

再評価は「後で必ず陽性になる」という意味ではありません。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019（詳細は記事参考文献）

髄液は「蛋白が高いか」だけで判断しない

蛋白・細胞数・発症からの時期を合わせる

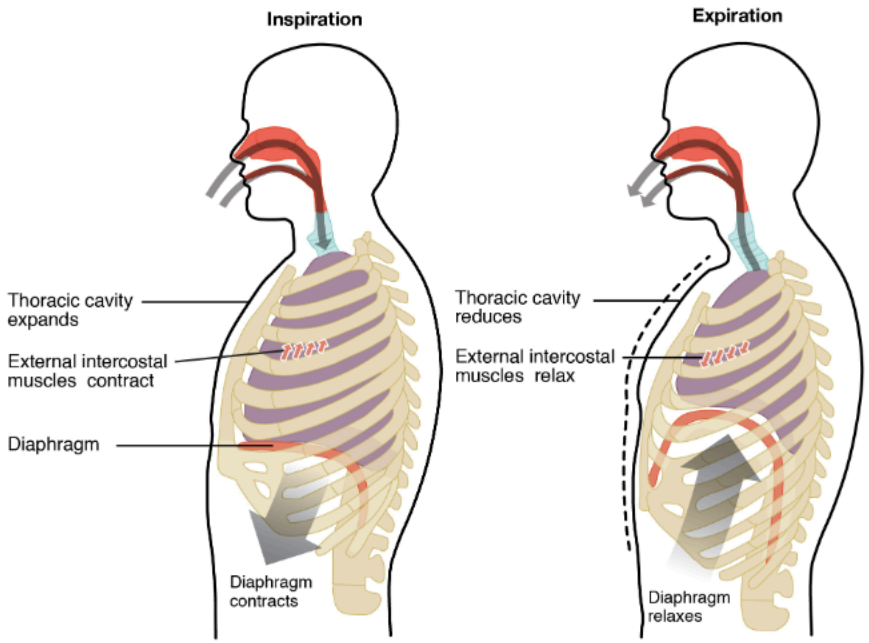
髄液の所見	解釈	次に考えること
蛋白細胞解離なし＋早期	GBSを否定しない	経過と検査時期を確認
細胞増多あり	他の病態にも注意	感染・炎症・腫瘍などを再検討
蛋白上昇だけ	単独で原因確定しない	症状・診察・他の検査と照合

腰椎穿刺は、適応・禁忌と安全性を先に評価します。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ EHA–ESMO 2024 ／ Merck Manual 2026（詳細は記事参考文献）

呼吸評価はSpO₂と自覚症状に依存しない

GBSを疑う場面では、呼吸・球症状・循環を経時的に確認



左：吸気／右：呼気（気道・胸郭・横隔膜）

正常な換気の説明図。肺活量の実測値や測定手技は示していません。

換気の評価

肺活量などの呼吸機能を経時的に評価します。SpO₂単独では判断できません。

気道を守る機能

嚥下と咳の強さを確認します。自覚的な息苦しさが乏しくても注意します。

自律神経の評価

心電図、心拍、血圧を監視し、変動や不整脈に注意します。

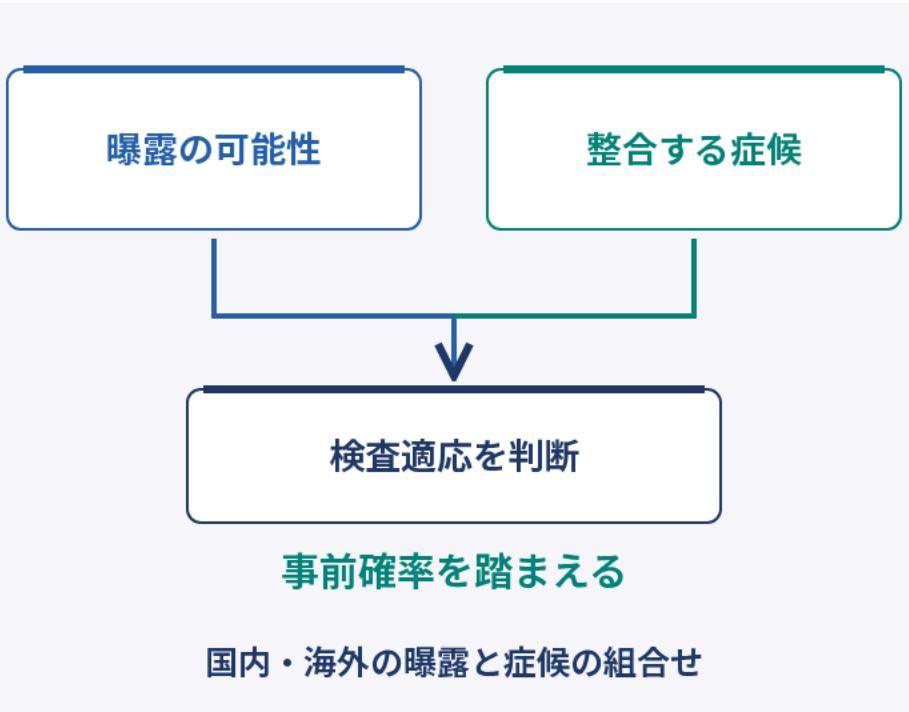
進行する障害があれば、集中管理・呼吸管理を検討します。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019（詳細は記事参考文献）

図：OpenStax College／CC BY 3.0（原画無変更）

Lyme病は渡航歴だけでなく国内曝露も聞く

国内の野外活動も含め、曝露と症候の整合性を確認する



曝露の可能性

北海道などでの野外活動、マダニ曝露、海外滞在を確認します。

整合する症候

紅斑、顔面麻痺、痛みを伴う神経根症状、髄膜症状を確認します。

検査の位置づけ

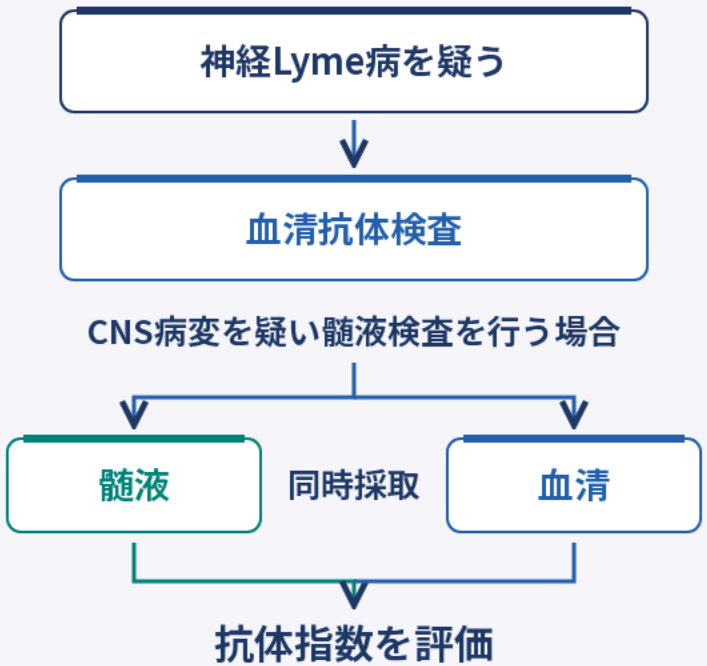
曝露と臨床像が合うときに検討。低い事前確率での一律検査を避けます。

北海道だけ、海外だけの病気として問診を狭めません。

主な出典：AAN/ACR/IDSA 2020 ／ JIHS 国内ライム病届出状況 ／ CDC 2025（詳細は記事参考文献）

神経Lyme病の検査は血清を基本に選ぶ

髄液は全例必須ではなく、中枢病変を疑う場合に適応を判断



まず血清抗体検査

神経Lyme病を疑う場合の基本となる検査です。

髄液検査を行う場合

同時採取した髄液と血清で、抗体指数を評価します。

単独結果の限界

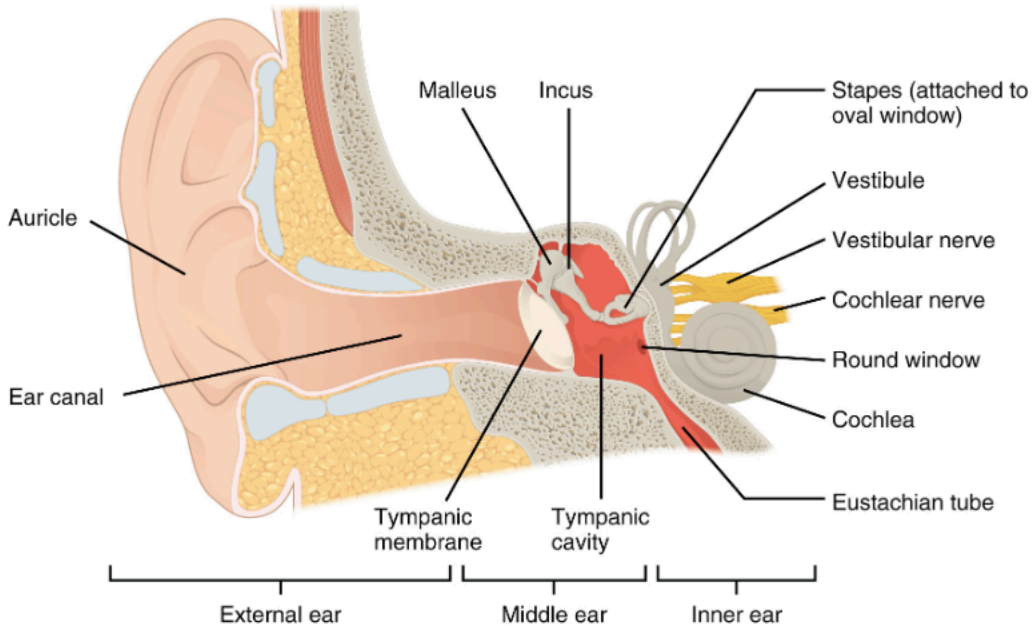
髄液抗体単独やPCR単独を根拠に、除外することはできません。

「顔面麻痺がある全員に腰椎穿刺」という手順ではありません。

主な出典：AAN/ACR/IDSA 2020（詳細は記事参考文献）

耳痛があれば外耳道と口腔まで診察する

Ramsay Hunt症候群などを考える所見は、顔面運動の外にもある



耳介・外耳道と中耳・内耳の正常解剖

皮疹や感染病変を示す図ではありません

耳介・外耳道・口腔

疼痛、水疱、発疹の有無を確認します。

聴覚・前庭症状

聴覚の変化や回転性めまいを聞き、関連する所見を評価します。

初診後も経過を確認

初診で発疹がなくても、後から現れる可能性を踏まえて再確認します。

片側での一般的な症候を鑑別の手がかりに用いています。

主な出典：MedlinePlus Ramsay Hunt 2026 ／ Pauna et al. 2024（詳細は記事参考文献）

図：OpenStax, Fig. 14.4／CC BY 4.0（原画無変更）

感染検査は症候・曝露・免疫状態で絞る

臨床条件から、必要な感染評価を選ぶ

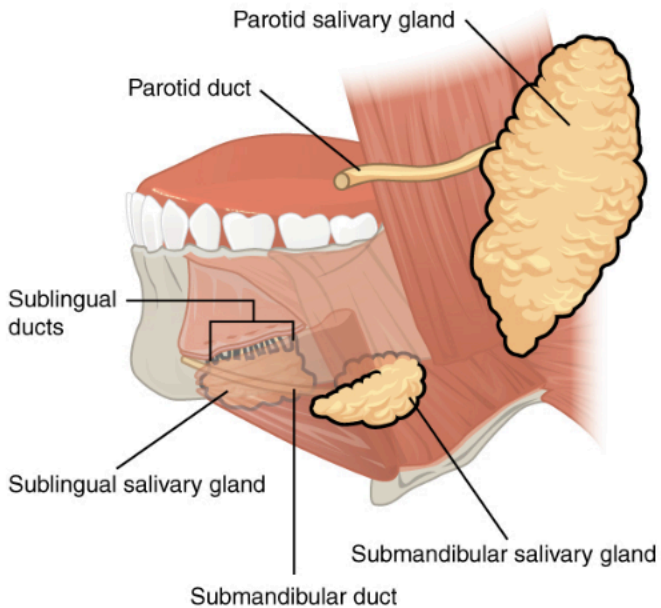
臨床条件	検討する病態・評価
発熱・発疹・リンパ節腫脹＋曝露歴	HIVなどの感染を検討
頭痛・項部硬直・羞明	髄膜炎を評価
亜急性経過・免疫抑制	結核・真菌なども候補

免疫状態が正常という理由だけで、感染は除外できません。

主な出典：Lin & Hu 2023 ／ CDC 2025 ／ Merck Manual 2026（詳細は記事参考文献）

顔面麻痺に眼と耳下腺の所見を重ねる

Heerfordt症候群を考える組合せを、診察部位と結びつける



耳下腺を含む唾液腺の正常解剖

腫脹やぶどう膜炎の症例像ではありません

顔面麻痺・眼・耳下腺

ぶどう膜炎と耳下腺腫脹を、顔面神経麻痺と合わせて確認します。

発熱と全身所見

皮膚、肺、リンパ節などにも関連所見がないか確認します。

組合せは手がかり

この組合せだけで確診せず、他の原因も含めて評価します。

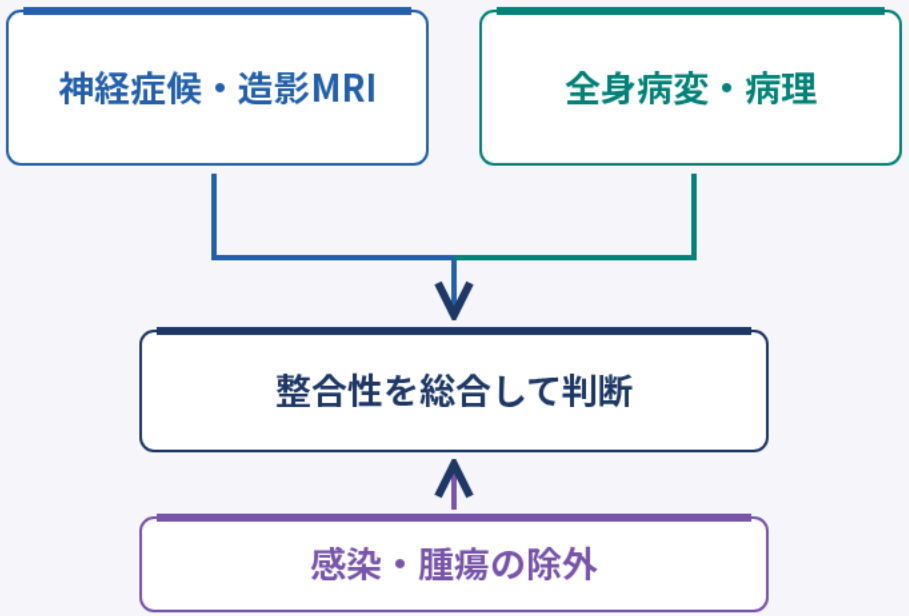
図は唾液腺の正常解剖です。耳下腺腫脹や眼の所見は、診察で確認します。

主な出典：Bradshaw et al. 2021（詳細は記事参考文献）

図：OpenStax College, Fig. 24.8／CC BY 3.0（原画無変更）

神経sarcoidosisは整合性と除外を組み合わせる

神経所見・全身病変・他疾患の除外を統合する



神経の所見

神経症候と造影MRIなどの所見が整合するか検討します。

全身病変と病理

病変の有無を確認し、適切な部位の生検を検討します。

他の原因の検討

感染や悪性腫瘍などを除外する評価を組み合わせます。

血液検査の結果だけで、確診・除外することはできません。

主な出典：Bradshaw et al. 2021 ／ Stern et al. 2018（詳細は記事参考文献）

進行性・多発脳神経障害では腫瘍性病変も考える

癌既往・多発脳神経障害・進行・リンパ節などが手がかり

疑う病態・場面	目的に応じた検査・再評価
固形癌の髄膜播種を疑う	造影MRIと髄液細胞診
リンパ腫を疑う	状況に応じて細胞診とフローサイトメトリー
初回陰性でも髄膜播種の疑いが残る	条件を整えた髄液の再検を1回検討

初回陰性という結果だけで、腫瘍性病変の検討を終えません。

主な出典：EANO–ESMO 2023 ／ EHA–ESMO 2024（詳細は記事参考文献）

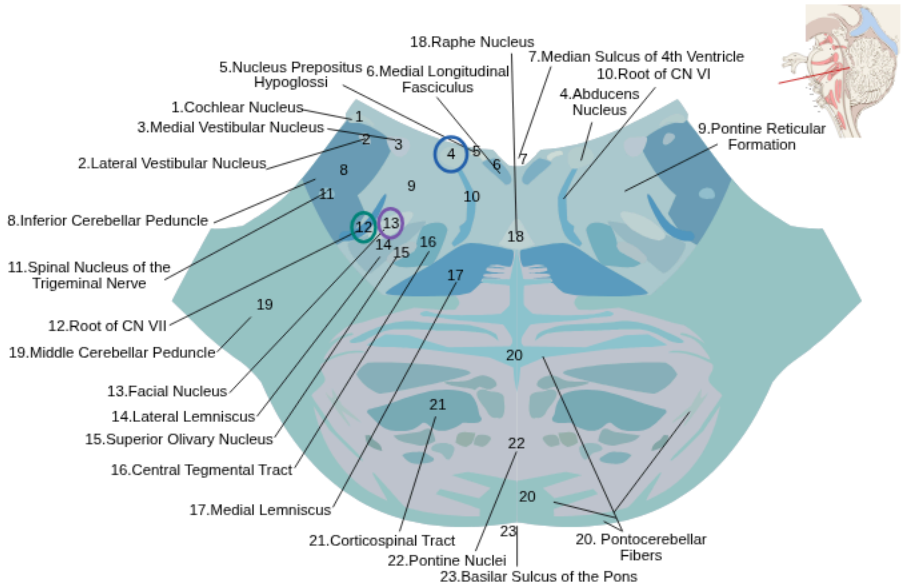
額を含む麻痺でも橋病変は除外できない

橋の核・橋内線維の障害でも、末梢性パターンを来し得る

外転神経核（4）

顔面神経根（12）

顔面神経核（13）



橋下部の正常解剖（上が背側）

4：外転神経核　13：顔面神経核　12：顔面神経根

核・根の位置を示す図。内膝の走行全体は表示していません。

片側の経路（概念）

顔面神経核
↓
同側の外転神経核の周囲を回る
↓
同側の顔面へ

額・閉眼・口の麻痺

橋の顔面神経核や橋内線維の障害でも、これらの部位が弱くなり得ます。

随伴する神経所見

突然発症、眼球運動、構音、失調、四肢の異常を確認します。

正常な橋の横断面です。単一の片側病変で両側麻痺を説明する図ではありません。

主な出典：Min & Jung 2019 ／ Webb et al. 2021（詳細は記事参考文献）

図：M. Strother; locator: P. J. Lynch／CC BY 3.0（原画無変更）

外傷・耳科手術・出生時からの弱さを分けて聞く

それぞれ独立した病歴の入口として確認する

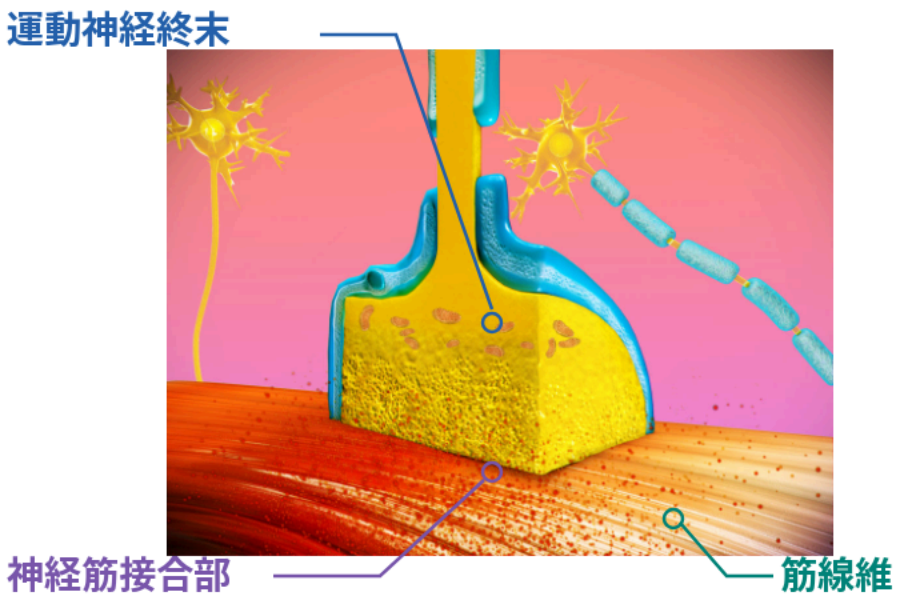
頭部外傷後	発症との時間的関係、外傷の状況を確認します。	**側頭骨骨折などを検討**
耳科手術後	手術の内容、側、麻痺が出現した時期を確認します。	**手術歴と症候を照合**
出生時から	眼球運動、発達歴、随伴異常を評価します。	**後天的な発症と区別**

時間的に前後しているという理由だけで、因果は断定できません。

主な出典：Webb et al. 2021 ／ Ghiasi & Banaei 2016 ／ Linder et al. 2017（詳細は記事参考文献）

MGでは「変動する顔面筋力低下」を捉える

活動・休息との関係と、眼・球症状の変動が手がかり



運動神経終末から筋線維への伝達部位

正常接合部の概念図。MGの受容体病変は表していません。

活動で増悪・休息で改善

顔面筋力低下の変動を、時間経過と活動に沿って確認します。

眼と球症状

眼瞼下垂・複視、構音・嚥下の変動を確認します。

神経筋接合部を疑う

臨床像に応じ、抗体検査や電気生理検査を検討します。

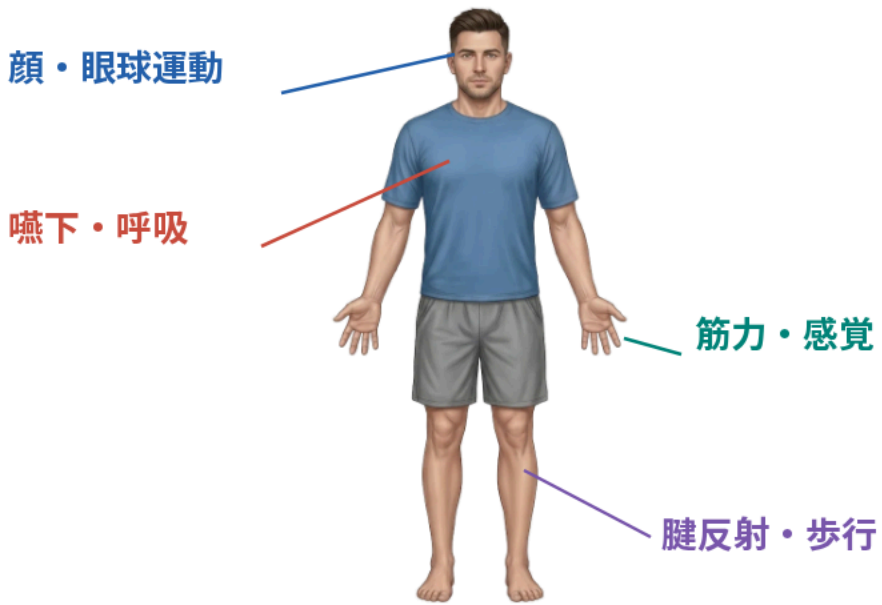
呼吸・嚥下障害があれば、緊急に評価します。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ MedlinePlus MG 2025（詳細は記事参考文献）

図：Doctor Jana／CC BY 4.0（原画無変更）

診察の範囲を顔から全身へ広げる

所見を集め、局在と病態の仮説につなげる



顔の外へ、診察範囲を広げる
診察部位の参考図（症例像ではありません）

眼・耳・口腔

眼球運動と眼の所見、耳・口腔、聴覚・前庭症状を確認します。

四肢の神経所見

筋力・反射・感覚を調べ、末梢神経と中枢の可能性を考えます。

全身に関連する所見

皮膚・耳下腺・リンパ節を確認し、感染・全身炎症・腫瘍を検討します。

顔面麻痺の診察を、顔の観察だけで終えません。

主な出典：Yang & Dalal 2021 ／ Bradshaw et al. 2021 ／ MedlinePlus MG 2025（詳細は記事参考文献）
図：Human Bio Media／CC BY 4.0（原画無変更）　Access for free at https://humanbiomedia.org/

検査は「何を確かめたいか」から選ぶ

全員に同じ検査を並べず、疑う病態と検査の目的を対応させる

臨床上の仮説
何を確かめる検査か？

GBS
NCS・髄液
初期正常でも必要に応じ再評価

脳幹・髄膜病変
目的に応じたMRI・髄液
局在・病態の仮説に合わせる

感染
血清・髄液検査
曝露と症候に応じて選ぶ

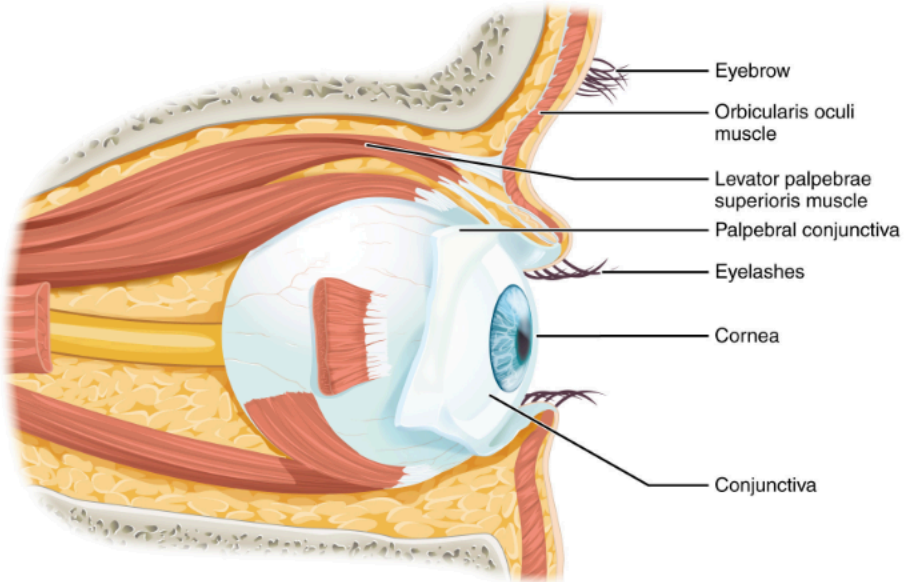
リンパ腫
細胞診・フローサイトメトリー
臨床像と他の検査を合わせる

腰椎穿刺は、適応・禁忌と安全性を確認して選択します。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ AAN/ACR/IDSA 2020 ／ EHA–ESMO 2024（詳細は記事参考文献）

原因検索を待たず角膜を守る

閉眼不全による角膜露出は、原因検索と並行して対応する



正常な眼と眼瞼（右が前方）
Cornea＝角膜（眼の前面）
閉眼不全の病像を示す図ではありません

確認する所見

閉眼の状態と角膜知覚、眼痛・異物感・かすみ・充血などを確認します。

眼表面の保護

潤滑と閉瞼を保つ対応を行います。手技は診療側で個別に判断します。

早い眼科評価

角膜障害が疑われる場合は評価を急ぎます。角膜知覚低下にも注意します。

図は露出と保護の説明です。自己判断で行うテープ手技の手順図ではありません。

主な出典：CDC 2025 ／ Mathenge 2018（詳細は記事参考文献）
図：OpenStax College, Fig. 14.11／CC BY 3.0（原画無変更）

Bell麻痺の推奨は対象を確かめて適用する

鑑別を続けることと、必要な治療機会を逃さないことを両立する

診療の状況	推奨の扱い
原因未確定の両側麻痺	Bell麻痺の治療を一律に適用しない
Bell麻痺と臨床判断	適切な早期治療を遅らせない
Lyme病関連の顔面麻痺	ステロイド追加には知識の空白がある

対象疾患と推奨条件を確認してから、治療に適用します。

主な出典：AAN/ACR/IDSA 2020 ／ 顔面神経麻痺GL公開概要 2025（詳細は記事参考文献）

正常・温存の所見だけで候補を捨てない

除外の根拠にしてしまいやすい所見を、次の判断へつなぐ

一見安心に見える所見	残る可能性・次の確認
手足の筋力が保たれている	末端の感覚、反射、経過も確認
初期の髄液・NCSが正常	発症からの時期を確認し、必要なら再評価
額も動かない	橋の顔面神経核・橋内線維の病変も検討

一つの正常所見、一つの局在所見だけで候補を捨てません。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Min & Jung 2019 ／ Susuki et al. 2009（詳細は記事参考文献）

初診から再評価までを一つの計画にする

安全確保は継続し、診察・仮説・検査・経過を結びつける

継続して確認：呼吸・嚥下・循環・角膜の安全

1　診察・時間経過

左右の発症と顔面運動
顔以外の神経・全身所見

→

2　局在と仮説

所見の組合せから
候補となる病態を考える

→

3　目的に応じた検査

仮説に対応する検査を選び
検査時期も記録する

→

4　結果と経過の照合

臨床像との整合性を確認
悪化・新所見にも注意

↑　悪化・新所見・不整合なら緊急性を再評価し、仮説と検査を見直す　←

初回検査で終わるのではなく、再評価までを計画に含めます。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019 ／ Yang & Dalal 2021（詳細は記事参考文献）

困った場面から原資料へ戻る

診療で迷った目的に合わせて、記事の正式書誌・リンクを参照

確認したいこと	主な原資料
GBSの診断・呼吸管理	日本神経学会 2024／Leonhard et al. 2019
Lyme病の検査・国内曝露	AAN/ACR/IDSA 2020／JIHS 国内届出状況
髄膜播種の診断	EANO–ESMO 2023 Clinical Practice Guideline
Bell麻痺の診療	国内2023診療指針の2025公開概要

ここでは短縮書誌を示しています。正式書誌とリンクは記事参考文献にあります。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ AAN/ACR/IDSA 2020 ／ EANO–ESMO 2023（詳細は記事参考文献）

資料の種類と適用限界も引き継ぐ

結論だけでなく、資料の種類と適用できる範囲も確認する

資料の種類	今回の使い方	適用上の注意
診療指針	診断・検査・管理の推奨	対象疾患・地域・条件を確認
症例報告・症例集積	病態や所見の存在の確認	一般患者の頻度にはしない
原著抄録のみ	Susuki／sarcoid基準／耳科手術	抄録で確認した範囲に限定
公的概説	症候と検査の基本概念	詳細な治療判断を補完しない

原因の割合・順位、投与量は提示していません。

主な出典：Susuki et al. 2009 ／ Stern et al. 2018 ／ Linder et al. 2017（詳細は記事参考文献）

最後までご視聴いただき、ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

次回の動画も、どうぞお楽しみに。

個々の治療方針は、担当の先生の判断によります。

気になることがあれば、次の受診のときに、相談してみてください。

急な息苦しさ・飲み込みにくさ・急速な脱力は、次の受診を待たず救急の医療機関へ相談してください。

主な出典：日本神経学会 2024 ／ Leonhard et al. 2019（詳細は記事参考文献）